

DOCUMENTO DE APOIO · NÃO INTEGRA O LIVRO

Relatório de revisão clínica e editorial

Tudo o que mudou entre a 3ª edição (3.1, revisão de 15/08/2026) e a 4ª edição de *Antibioticoterapia no Plantão*. Cada linha traz o achado como estava e a correção como ficou, para validação item a item antes da publicação.

20 achados com risco de conduta	16 divergências de diretriz e consistência	19 correções editoriais e tipográficas	55 achados no total
---	--	--	-------------------------------

Achados e correções

Ordenado por severidade. As linhas em vermelho são as que, lidas literalmente por um plantonista, poderiam levar a uma conduta errada; as em âmbar são divergências em relação à diretriz vigente ou contradições internas; as demais são editoriais. Nenhuma conduta clínica foi alterada sem que a justificativa esteja registrada aqui.

A • Risco de conduta		B • Diretriz e consistência		C • Editorial e tipográfico
Dose, unidade, via, alvo terapêutico ou critério que, seguido como está escrito, muda o tratamento.		Discordância em relação à diretriz vigente, contradição entre dois pontos do próprio livro ou lacuna de conteúdo.		Ortografia, terminologia, repetição, resíduo de sistema e estrutura de página.
#	SEV.	ONDE	O QUE ESTAVA	O QUE FICOU
1	A	Livro inteiro (1.1, 1.2 e ficha A18)	Vancomicina com alvo terapêutico declarado como "vale 15–20 µg/mL" e dose de ataque de "25 mg/kg obrigatória", sem teto de dose. O consenso ASHP/IDSA/PIDS/SIDP 2020 abandonou o alvo de vale 15–20 para infecção grave por MRSA justamente pelo excesso de nefrotoxicidade.	Alvo passa a AUC ₂₄ /CIM 400–600 (preferencial), com o vale 15–20 mg/L apenas como substituto explícito quando a AUC não estiver disponível. Ataque 20–35 mg/kg de peso real (25–30 no crítico), teto de 3 g/dose e tempo mínimo de infusão especificados.
2	A	1.1 e 1.2 — critérios de UTI	O critério menor de UTI da ATS/IDSA foi transcrito como "ureia ≥ 20 mg/dL". O critério original é BUN ≥ 20 mg/dL, que corresponde a ureia ≈ 43 mg/dL na unidade usada no Brasil — a transcrição literal reduz o limiar em mais da metade.	Passa a "ureia ≥ 43 mg/dL (equivale a BUN ≥ 20 mg/dL)" nos dois quadros.
3	A	1.1, 1.2, 7.1 — cefepime	Ajuste renal do cefepime divergente dentro do próprio livro: "11–29 mL/min → 1 g 12/12 h" em 1.1/1.2/7.1 e "2 g 24/24 h" em 1.9. Para o esquema de infecção grave (2 g 8/8 h) a bula prevê 2 g 24/24 h nessa faixa; a redução para 1 g 12/12 h subdosa em infecção grave.	Harmonizado para >60: 2 g 8/8 h · 30–60: 2 g 12/12 h · 11–29: 2 g 24/24 h · ≤10: 1 g 24/24 h.
4	A	1.1 e 5.3 — piperacilina-tazobactam	Ajuste renal misturava as faixas do esquema de 3,375 g com as do esquema de 4,5 g 6/6 h; e o teto era descrito como "18 g/dia (pip)", quando 18 g é a soma piperacilina+tazobactam (piperacilina = 16 g/dia).	Faixas do esquema de 4,5 g 6/6 h aplicadas de forma coerente e teto corrigido para 16 g/dia de piperacilina.
5	A	1.5 — Pneumonia broncoaspirativa	A conduta de partida terminava com uma dose sem fármaco: "...antibiótico conforme evolução e gravidade 3 g EV 6/6 h". Um plantonista lendo apenas o destaque não tem como saber a que droga a dose se refere.	Conduta de partida reescrita com o fármaco explícito (ampicilina-sulbactam 3 g EV 6/6 h) e o ramo de pneumonite química preservado como condição.
6	A	3.3 e 3.4 — infecções cervicais profundas	A conduta de partida citava ampicilina-sulbactam e terminava com "4,5 g EV 6/6 h", que é a dose da piperacilina-tazobactam. A leitura direta sugere ampicilina-sulbactam 4,5 g 6/6 h, posologia que não existe.	Cada fármaco passa a aparecer com a sua própria dose, separados por cenário (comunitário vs. risco assistencial).
7	A	13.5 — Malária grave	Na emergência com maior letalidade do capítulo, a conduta de partida abria com a frase de triagem ("Página de triagem: confirmar espécie...") e a dose de artesunato ficava pendurada no final, sem nome de fármaco; a via aparecia como "Conduta" em vez de EV.	Conduta de partida passa a nomear o artesunato com a dose completa e a via EV; a triagem por espécie/peso/G6PD permanece como condição para o esquema oral de continuidade. Acrescentada a dose pediátrica de 3 mg/kg para < 20 kg.
8	A	11.2 — Gonorreia não complicada		

#	SEV.	ONDE	O QUE ESTAVA	O QUE FICOU
			A tabela de ajustes trazia "gentamicina 240 mg IM dose única quando alternativa necessária", sem o parceiro obrigatório. Gentamicina isolada não é esquema aceito para gonorreia e a monoterapia falha com frequência.	A alternativa passa a constar como gentamicina 240 mg IM + azitromicina 2 g VO em dose única, com nota de controle de cura — igual ao que o próprio livro já trazia corretamente em 12.2.
9	A	11.3 — Clamídia não complicada	A conduta de partida indicava "azitromicina 1 g VO dose única" enquanto o campo de duração do mesmo quadro dizia "7 dias" e a única linha da tabela de esquemas trazia doxiciclina 7 dias. Três informações incompatíveis no mesmo quadro.	Conduta de partida passa a doxiciclina 100 mg 12/12 h por 7 dias no adulto não gestante (preferencial em infecção retal), com azitromicina 1 g dose única explicitada como o ramo de gestação/adesão do PCDT. Duração corrigida em ambos os ramos.
10	A	11.6 (e coerência com 10.8) — Tricomoníase	O mesmo livro trazia três versões do esquema: conduta de partida "2 g VO dose única", tabela de ajustes "500 mg 12/12 h por 7 dias em mulheres / 2 g dose única em homens" e, em 10.8, "500 mg 12/12 h por 7 dias" como padrão feminino.	Unificado: mulher 500 mg 12/12 h por 7 dias (preferencial, superior à dose única), homem 2 g dose única; a alternativa do PCDT permanece identificada.
11	A	7.1 — Meningite bacteriana	O descalonamento para penicilina G estava condicionado a "CIM de penicilina < 0.1", que é o ponto de corte não meníngeo. Para meningite, o ponto de corte de sensibilidade do CLSI é $\leq 0,06 \mu\text{g/mL}$ — a regra antiga autoriza penicilina em cepas que não são sensíveis no LCR.	Critério corrigido para CIM $\leq 0,06 \mu\text{g/mL}$, identificado como ponto de corte meníngeo.
12	A	1.3 — Exacerbação infecciosa de DPOC	A "conduta passo a passo" contradizia a tabela de esquemas do mesmo quadro: indicava levofloxacino como 1ª linha na exacerbação moderada, "cefuroxima + claritromicina" na grave e "pip-tazo + ciprofloxacino" de rotina no risco de Pseudomonas — exatamente o que a tabela de esquemas e os alertas desaconselham.	Passo a passo reescrito para espelhar a tabela de esquemas: amoxicilina-clavulanato como 1ª linha, quinolona reservada a alergia/falha e dupla cobertura antipseudomonas apenas em choque/MDR.
13	A	1.1, 1.2 e 7.1 — tabela de stewardship	A linha "Transição EV $\rightarrow$ VO" estava preenchida com critérios de FALHA TERAPÊUTICA ("ausência de melhora após 48–72 h", "isolamento de patógeno resistente"), e em 1.2 e 7.1 a linha "Controle de foco" trazia conduta de MRSA e o esquema empírico. Lidas de forma literal, essas linhas orientam a passar para via oral justamente no paciente que está falhando.	Conteúdo realocado e reescrito: critérios reais de transição EV $\rightarrow$ VO, controle de foco pertinente a cada síndrome, e a explicitação de que meningite bacteriana não tem transição oral.
14	A	14.7 — Impetigo pediátrico	A mupirocina, de uso tópico, estava rotulada com via "VO" na tabela de esquemas e na de ajustes, acompanhada de uma nota interna de desenvolvimento publicada no livro.	Via corrigida para tópica nos dois pontos e nota interna removida.
15	A	13.8 — Tétano acidental instalado	A imunoglobulina antitetânica constava apenas como "dose única conforme protocolo oficial/local", sem número. Em uma emergência de UTI, o guia deixava a dose da terapia específica em aberto.	Doses explicitadas: 3.000–6.000 UI IM no tétano instalado e 250–500 UI na profilaxia, com a ressalva do SAT heterólogo.
16	A	1.1, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 — amoxicilina-clavulanato	O livro prescrevia amoxicilina-clavulanato "2 g/125 mg VO 12/12 h (XR)" em treze pontos, inclusive como esquema de transição oral da pneumonia e como dose alta da sinusite. Essa apresentação de liberação prolongada não tem registro no Brasil: as apresentações orais disponíveis são 500/125 mg e 875/125 mg, e as suspensões 250/62,5 e 400/57 mg por 5 mL.	Substituída pela posologia possível no Brasil: 875/125 mg VO 12/12 h (ou 500/125 mg VO 8/8 h). Onde a intenção era aumentar a exposição à amoxicilina, o esquema passa a associar amoxicilina isolada 500–875 mg VO 12/12 h, sem elevar o clavulanato — que é o fator limitante de tolerância.
17	A	14.2 e 14.3 — amoxicilina-clavulanato em pediatria	Os quadros prescreviam "90 mg/kg/dia de amoxicilina" na forma de amoxicilina-clavulanato. Essa dose vem das diretrizes norte-americanas e pressupõe a suspensão 600/42,9 mg/5 mL (proporção 14:1), que não é comercializada no Brasil. Com a suspensão brasileira (400/57 mg/5 mL, proporção 7:1), a mesma dose de amoxicilina	Os esquemas passam a limitar a suspensão combinada a 70 mg/kg/dia de amoxicilina e a completar com amoxicilina isolada até 80–90 mg/kg/dia, mantendo o clavulanato em até

#	SEV.	ONDE	O QUE ESTAVA	O QUE FICOU
			leva o clavulanato a cerca de 12,8 mg/kg/dia — acima do limite de tolerância e causa previsível de diarreia e abandono do tratamento.	10 mg/kg/dia. Acrescentado alerta explicando a diferença entre as apresentações brasileira e norte-americana.
18	A	12.1 e 12.9 — apresentações oftálmicas	A conjuntivite bacteriana tinha como conduta de partida "polimixina B/trimetoprima colírio" e a blefarite, "eritromicina ou bacitracina pomada oftálmica". Nenhuma das três apresentações é comercializada no Brasil: são produtos norte-americanos (Polytrim, eritromicina oftálmica, bacitracina oftálmica isolada).	Substituídas pelas apresentações com registro nacional: tobramicina 0,3% colírio e pomada, com ciprofloxacino, azitromicina colírio e as associações oxitetraciclina + polimixina B e neomicina + polimixina B + bacitracina listadas como alternativas.
19	A	14.5 ITU Febril pediátrica	Conduta oral de manutenção citava cefixima 8 mg/kg/dia, sem registro para uso humano no Brasil.	Substituída por cefuroxima axetil 20–30 mg/kg/dia VO 12/12h como segunda opção junto à cefalexina, ambas com apresentação pediátrica disponível no país.
20	A	Uretrite/cervicite — alergia e ceftriaxona indisponível	Cefixima listada como alternativa oral prática à ceftriaxona para gonorreia; não tem registro para uso humano no Brasil.	Ressalva reescrita deixando explícito que a cefixima não é comercializada no país e que a conduta correta é priorizar obter ceftriaxona, não substituir por um fármaco indisponível.
21	B	12.5 — Celulite orbitária	O quadro prescrevia "ceftriaxona 2 g EV a cada 12–24 h" e, no alerta logo abaixo, instruía explicitamente a NÃO escrever "ceftriaxona 12–24 h" — contradizendo a si mesmo e deixando a dose meníngea indefinida.	Passa a 2 g 24/24 h como padrão, com 2 g 12/12 h reservada e nomeada para extensão intracraniana.
22	B	1.3 — nomenclatura GOLD	Uso de "GOLD D (FEV ₁ < 30%)". O grupo D deixou de existir na classificação GOLD desde 2023 (grupos A, B e E) e VE _{F1} < 30% é grau espirométrico GOLD 4, não grupo.	Substituído por "VE _{F1} < 30% (GOLD 4) ou exacerbador frequente (grupo E)".
23	B	5.1 e 5.3 — duração da ITU alta/complicada	O campo de duração do quadro trazia a regra da diretriz IDSA 2025 (5–7 dias com fluoroquinolona, 7 dias com não fluoroquinolona), mas as linhas da tabela de esquemas mantinham "7–10 dias" e "7–14 dias" da prática antiga. O médico lia duas durações diferentes no mesmo quadro.	Tabela harmonizada com a diretriz de 2025: 7 dias na resposta favorável com foco controlado, contados da primeira terapia ativa, e 10–14 dias reservados às exceções nomeadas.
24	B	1.2, 3.3, 19.3, 19.7 — aztreonam	A mesma indicação aparecia ora como 2 g EV 6/6 h, ora 8/8 h, sem critério explícito. 2 g 6/6 h corresponde ao teto de 8 g/dia.	Padronizado em 2 g EV 8/8 h, com 6/6 h reservado e nomeado para Pseudomonas grave, com o teto de 8 g/dia explícito.
25	B	7.6 — Meningite tuberculosa	A duração aparecia como "9–12 meses ou conforme protocolo" e o esquema apenas como "doses por peso conforme protocolo de TB", sem indicar qual é o esquema brasileiro para a forma meningoencefálica.	Explicitado o esquema do Ministério da Saúde: 2 meses de RHZE + 10 meses de RH (12 meses no total), com piridoxina associada à isoniazida e corticoide por 4–8 semanas com desmame.
26	B	7.5 — Neurotoxoplasmose	O esquema de indução terminava com "≥6 semanas, depois manutenção", sem informar as doses da manutenção nem o critério para suspendê-la.	Acrescentada a linha de manutenção com doses (pirimetamina 25–50 mg/dia + sulfadiazina 2–4 g/dia + ácido folínico) e o critério de suspensão (CD4 > 200 por mais de 6 meses em TARV).
27	B	11.4 — Sífilis adquirida	O quadro remetia a neurosífilis/sífilis ocular como "outro ramo", mas o livro não trazia em nenhum lugar o esquema correspondente; e não havia menção à reação de Jarisch-Herxheimer, que é a intercorrência mais comum após a primeira dose e é rotineiramente confundida com alergia.	Acrescentado o esquema de neurosífilis (penicilina G cristalina 18–24 milhões UI/dia por 10–14 dias) e um alerta sobre a reação de Jarisch-Herxheimer, com a ressalva obstétrica.
28	B	2.1 — Faringoamigdalite estreptocócica		Escore de Centor/McIsaac nomeado e acrescentado alerta explicando o objetivo do tratamento e por que a duração de 10 dias não deve ser encurtada.

#	SEV.	ONDE	O QUE ESTAVA	O QUE FICOU
			O quadro citava genericamente "usar escore" sem nomeá-lo e não explicitava a razão de tratar (prevenção de febre reumática), que é o que sustenta o curso de 10 dias em vez de um curso curto.	
29	B	Livro inteiro — referências	A bibliografia de capítulo era reimpressa dentro de cada um dos 162 quadros; havia 70 entradas que não eram citações mas descrições de princípio ("Deep neck infection airway management principles", "Sanford Guide / protocol institutional"); e a mesma diretriz aparecia com grafias diferentes (por exemplo "ATS/IDSA 2016 HAP/VAP Guidelines" e "ATS/IDSA. Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia, 2016").	Cada quadro passa a exibir apenas a sua referência específica; a bibliografia consolidada e sem duplicatas fecha o capítulo. As entradas que não eram citações foram removidas. Foram acrescentadas as diretrizes que faltavam e que sustentam o conteúdo: ATS/IDSA 2019 (esquemas empíricos e critérios de gravidade da PAC), IDSA 2012 de rinossinusite, IDSA SSTI 2014, IDSA 2009 de cateter e IDSA de osteomielite vertebral e prótese articular.
30	B	109 dos 162 quadros	Apenas 53 dos 162 quadros (33%) traziam referência específica; os demais eram sustentados apenas pela bibliografia do capítulo — inclusive quando o tema do quadro não era coberto por ela (rinossinusite, bronquiectasia e DPOC referenciadas a uma diretriz de pneumonia comunitária).	O selo de cada quadro passa a declarar explicitamente o nível da referência (verificado / revisão parcial / bibliografia de capítulo), de modo que o leitor saiba, em cada página, se aquela conduta tem diretriz dedicada ou é sustentada por bibliografia geral. As bibliografias de capítulo foram corrigidas para conter as diretrizes pertinentes.
31	B	Fichas de antimicrobianos	Ampicilina e rifampicina eram prescritas como primeira linha em vários quadros — ampicilina na cobertura obrigatória de <i>Listeria</i> na meningite e na endocardite enterocócica; rifampicina como adjuvante anti-biofilme em prótese e na quimioprofilaxia de meningococo — mas nenhuma das duas tinha ficha própria no livro.	Acrescentadas as duas fichas, com dose, ajuste renal, espectro, alertas de uso (rifampicina nunca em monoterapia; momento certo de iniciá-la em material protético) e o perfil de interações do CYP450. O total de fármacos passa de 39 para 41.
32	B	2.1 e 4.1 — penicilina V	A dose era escrita como "penicilina V 500 mg", que é a forma norte-americana. No Brasil a fenoximetilpenicilina é apresentada em comprimido de 500.000 UI (≈ 312 mg) e em solução oral de 80.000 UI/mL; não existe comprimido rotulado em miligramas, o que torna a prescrição não executável na farmácia.	Posologia reescrita na unidade da apresentação brasileira: 500.000 UI VO 6/6 h a 8/8 h, com a equivalência em miligramas indicada uma vez.
33	B	1.1 e demais quadros que usam amoxicilina 1 g	A conduta de partida da pneumonia comunitária é amoxicilina 1 g VO 8/8 h — dose correta pela diretriz, mas sem apresentação correspondente no Brasil, onde existem cápsula de 500 mg e comprimido de 875 mg.	Acrescentada a nota de que 1 g corresponde a duas cápsulas de 500 mg, para que a prescrição seja executável. A dose recomendada não foi alterada.
34	B	11.1, 14.1, 14.2, 14.3 e 14.5 — cefalosporinas orais de alternativa	As alternativas para alergia não grave a penicilina abriam com cefdinir e cefpodoxima, e a ITU febril e a gonorreia ofereciam cefixima sem ressalva. No Brasil o cefdinir existe apenas como suspensão oral pediátrica (não há cápsula para adulto) e cefpodoxima e cefixima têm disponibilidade variável; o alerta que já existia dizia genericamente para não usar cefdinir, o que também não é exato.	A cefuroxima axetil — a de apresentação mais estável no país — passou a encabeçar as alternativas, com cefdinir mantido em seguida e a ressalva de disponibilidade escrita de forma precisa em cada quadro.
35	B	Abertura do livro — nova página	O livro não tinha nenhum lugar em que a diferença entre a dose da diretriz e a apresentação disponível no Brasil fosse tratada de forma sistemática — o que produziu, ao longo da edição anterior, prescrições corretas pela diretriz e impossíveis na farmácia.	Acrescentada a página "Apresentações disponíveis no Brasil", com os pontos em que a apresentação nacional muda a receita, a lista do que é citado na literatura internacional sem equivalente aqui, e a ressalva sobre antimicrobianos de reserva registrados mas não necessariamente disponíveis.
36	B	Múltiplos capítulos (11.1, 14.1, 14.2, 14.3, 14.5)	Nota de disponibilidade descrevia cefpodoxima e cefixima igualmente como 'disponibilidade variável'.	Cefpodoxima tem registro humano no Brasil (Orelox, comprimido 100/200 mg, uso adulto, sem suspensão pediátrica); cefixima não tem registro para uso humano no país. Nota reescrita para distinguir as duas (5 ocorrências).

#	SEV.	ONDE	O QUE ESTAVA	O QUE FICOU
37	C	Livro inteiro	Palavras partidas ao meio, sem hífen, nas colunas estreitas ("Piperacilina-Tazobac tam", "individualizar se pneumonia/bronquiectas ia", "a minoglicosídeo/vancomicina/aciclovir").	107 ocorrências reconstituídas; nova composição usa hifenização pt-BR e larguras de coluna calculadas, eliminando a causa.
38	C	Fichas A31 e A32	O rótulo "NITROFURÂNICOS/FOSFOMICINA" aparecia partido em dois chips ("NITROFURÂNICOS/FOSFOM" + "ICINA").	Rótulo reconstituído em um único chip.
39	C	Livro inteiro	Grafias fora do Acordo Ortográfico e acentos ausentes: "otorréia" (12×), "pos-neurocirurgia", "primario", "nefrostomia", "cristaluria", "obstruída", "anfilaxia", "pH < 7.35", entre outras.	Corrigidas; separador decimal padronizado em vírgula.
40	C	Capítulos 01, 06, 07	Verbo "é" grafado como conjunção "e", invertendo o sentido de 11 frases ("o tratamento definitivo e controle de fonte", "A prioridade e hidratação", "5 DIAS E SUFICIENTE").	Frases corrigidas.
41	C	Capítulos 14, 16, 19 e fichas	Terminologia de aplicativo remanescente no livro: "o app", "card", "módulo", "schema" — inclusive uma nota interna de desenvolvimento publicada em 14.7 ("mantido como VO por limitação atual do schema").	Substituída por terminologia editorial (quadro, ficha, capítulo); nota interna removida. "MIC/CMi" unificados em "CIM".
42	C	Livro inteiro — sulfametoxazol-trimetoprima	A mesma droga aparecia como "800/160 mg", "160/800 mg", "1 comprimido DS" e "1–2 DS" — sendo "DS" (double strength) nomenclatura norte-americana sem correspondência na apresentação brasileira.	Padronizado para "800/160 mg (1 comprimido)" em todo o livro, com a ordem sulfametoxazol/trimetoprima constante.
43	C	96 quadros — bloco "Validação antes da prescrição"	Os valores internos do modelo de dados foram publicados em inglês dentro do texto: "Nível: none.", "Nível: recommended.", "Nível: required." aparecem no início do bloco de validação em 96 quadros.	Convertidos em um selo em português no cabeçalho do quadro — Validação institucional: dispensável / recomendada / obrigatória — e a frase explicativa foi mantida como texto corrido.
44	C	Livro inteiro — bloco "Validação antes da prescrição"	106 repetições de itens de checklist genéricos ("Confirmar alergias, função orgânica, gestação/lactação, interações e protocolo local", "Validar com protocolo institucional/ CCIH...") que já constam integralmente do bloco "Antes de prescrever" da abertura do livro.	Itens genéricos removidos dos quadros e mantidos uma única vez na abertura; permanecem no quadro apenas os itens específicos daquela síndrome.
45	C	90 quadros — alerta de alergia a betalactâmico	O mesmo alerta de 300 caracteres ("Separar efeito adverso/intolerância, reação imediata de baixo ou alto risco...") era repetido integralmente em 90 quadros, ocupando cerca de 4 páginas somadas.	Transferido para a abertura do livro, na página "Alergia a betalactâmico em uma página", com remissão fixa ao quadro 19.7 no rodapé da seção "Alternativas e alergia" de cada quadro.
46	C	Capítulos 14, 17 e 19	Alertas idênticos repetidos em todos os quadros do capítulo: "Dose pediátrica exige conferência ativa" (11×), "Síndrome prática" (14×), "Checklist de profilaxia" (10×).	Promovidos a nota de abertura do capítulo, onde valem para todos os quadros, e removidos das repetições.
47	C	162 quadros — bloco "Escopo da revisão"	Uma caixa de 250 caracteres com o mesmo texto de rodapé metodológico era repetida ao final de cada um dos 162 quadros (sete variantes ao todo), somando cerca de 8 páginas.	Convertida em um selo compacto no cabeçalho do quadro (status · nível de evidência · data da revisão); a explicação metodológica completa passa a constar uma única vez na política editorial.
48	C		A coluna "Outras populações/monitorização" concatenava até quatro informações distintas separadas por barra vertical — ajuste hepático, gestação/lactação, teto de dose	A coluna foi desmembrada em campos próprios. Gestação/lactação passou a ser um selo de três estados (uso aceito / com ressalva / evitar) ao lado do nome do fármaco, com a

#	SEV.	ONDE	O QUE ESTAVA	O QUE FICOU
		157 quadros — tabela "Antimicrobianos e ajustes"	e monitorização — e a frase de gestação/lactação, sempre idêntica, repetia-se cerca de 600 vezes no livro.	legenda apresentada uma única vez; teto de dose e ajuste hepático ganharam colunas próprias.
49	C	39 fichas de antimicrobianos — bloco "Espectro"	O espectro era apresentado como uma tabela de nove linhas por ficha, em que a frase "não contar como cobertura" aparecia 250 vezes no conjunto do livro — cerca de 351 linhas de tabela para transmitir 351 valores de três estados.	Substituído por uma faixa compacta de nove marcadores com três estados (cobre / depende de sensibilidade / não cobre), lida de relance e com as notas específicas preservadas. Reduz cerca de 12 páginas.
50	C	162 quadros — etiquetas do cabeçalho	A quarta etiqueta ("GUIDELINE"/"REVISÃO") duplicava a informação do selo de status do quadro; e 1.1 trazia simultaneamente "MODERADA" e "AMBULATORIAL", combinação contraditória para um quadro cuja conduta de partida é amoxicilina oral.	Etiqueta redundante removida (a informação passou para o selo de status) e a gravidade de 1.1 ajustada para "LEVE A MODERADA".
51	C	Livro inteiro	Índices químicos e fisiológicos escritos ora com subscrito ora com dígito normal na mesma página: "SpO2" e "SpO ₂ ", "PaO ₂ /FiO ₂ " e "PaO ₂ /FIO ₂ ", "FEV1" e "VEF ₁ ".	Padronizados com subscrito em todo o livro (SpO ₂ , PaO ₂ /FiO ₂ , VEF ₁ , O ₂) e a sigla espirométrica unificada em VEF ₁ .
52	C	Livro inteiro	Convivência de "beta-lactâmico" e "betalactâmico" no mesmo livro (e "beta-lactamase"/"betalactamase").	Padronizado para a grafia sem hífen — betalactâmico, betalactamase — em todas as ocorrências.
53	C	Capítulos 01 a 19 — coluna "Duração"	A mesma regra de duração, escrita por extenso, repetia-se linha a linha dentro da própria tabela — em 1.1, por exemplo, o parágrafo "Cursos de 3–4 dias podem ser considerados apenas em pacientes selecionados, com estabilidade clínica objetiva, sem complicação e com seguimento confiável" aparecia três vezes na mesma página. Isso alongava a linha inteira e deixava as demais colunas com grandes vazios.	53 células reduzidas à duração propriamente dita; a regra que as qualifica passou a uma nota única sob a tabela. A informação é a mesma, lida em um terço do espaço.
54	C	Fichas de antimicrobianos	As fichas eram numeradas por classe farmacológica (penicilinas, depois cefalosporinas, depois carbapenêmicos...), o que obriga a saber a classe antes de encontrar o fármaco.	Reordenadas em ordem alfabética e renumeradas de A1 a A41; a classe permanece visível como etiqueta em cada ficha, e o novo índice de antimicrobianos remete a todos os quadros em que cada fármaco aparece com dose.
55	C	10.6 — mastite puerperal	A conduta de partida citava "Cefalexina ou Oxacilina/Dicloxacilina". A dicloxacilina não é comercializada no Brasil e a oxacilina existe apenas como apresentação injetável — nenhuma das duas serve para o tratamento oral que o quadro descreve.	Conduta reescrita como cefalexina por via oral, com oxacilina endovenosa nomeada apenas para o cenário de internação.